UE D1.1 · SEMESTRE 1 · SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2026

L'ENTRETIEN INFIRMIER

Fiche de révision écrite

SOURCES DU COURS

Support de Pascaline GRARE (IFSI Antoine Béclère, octobre 2026) et notes orales de la séance (deux parties).

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre l'entretien comme soin relationnel, **choisir une forme de conduite adaptée** et savoir préparer, mener, conclure et transmettre un échange avec la personne soignée.

Questions du support
Définition • types • techniques • objectifs • étapes • facteurs influençant l'entretien.

Lecture à deux niveaux
Essentiel : la notion à retenir.
Pour comprendre : l'explication et les nuances de l'oral.
En pratique : application aux soins.

Méthode : les 5 étapes du support

Étape	Réflexe clinique
1 · Préparation	Pourquoi, où, quand, combien de temps ?
2 · Orientation	Qui suis-je, quel objectif, accord du patient ?
3 · Exploration	Qu'exprime la personne, quels outils utiliser ?
4 · Conclusion	Qu'a-t-on compris ou décidé ? Et ensuite ?
5 · Évaluation/transmissions	Que retenir et transmettre utilement ?

Sommaire rapide — repères de lecture

À PARCOURIR

01–03 Fondamentaux, catégories et techniques
04–09 Objectifs de l'entretien
10–14 Les cinq étapes du déroulement
15–16 Influences et situations cliniques
Fin Pièges QCM · Synthèse · Définitions

RÉFLEXE DE PARTIEL

Dans une vignette, distinguer **l'objectif** de l'entretien, **l'organisation** (formel/informel), **la technique** (directif, semi-directif, non directif) et les **étapes**. Ces termes ne sont pas synonymes.

01 Un soin relationnel, avec une finalité

ESSENTIEL

Un entretien infirmier est un **soin relationnel orienté vers des objectifs précis**, dans une situation précise. Ce n'est ni une simple conversation ni un interrogatoire.

POUR COMPRENDRE

Le support mobilise deux définitions : Martine **Mazoyer** met l'accent sur l'expression verbale de la personne et les objectifs de soins ; une seconde définition souligne l'échange, l'information, l'expression des difficultés et le recueil de données permettant de construire ensemble le projet de soins.

La formatrice rappelle que l'entretien suppose une **interaction**. La posture, les questions, les informations données et les réactions du patient influencent son déroulement. Une grille peut guider le soignant, mais ne doit pas étouffer ce que le patient exprime spontanément.

L'intention soignante ne consiste donc pas seulement à « poser des questions ». Selon la situation, elle peut être de comprendre un besoin, transmettre une information, apporter un soutien, préparer une décision ou aider la personne à envisager un changement.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Un patient s'inquiète d'un traitement nouvellement prescrit. L'IDE ne déroule pas automatiquement une liste d'effets indésirables : il cherche d'abord la question précise du patient, explique avec des mots adaptés et vérifie ce qui reste à éclaircir.

02 Trois axes différents pour classer les entretiens

ESSENTIEL

Formel/informel décrit surtout l'organisation ; **individuel/familial** décrit les participants ; **directif/semi-directif/non directif** décrit la manière de conduire l'échange.

POUR COMPRENDRE

Un entretien **formel** est planifié et cadré : des objectifs sont définis et verbalisés, le lieu et le temps sont envisagés. La formatrice évoque des rendez-vous de suivi programmés dans sa pratique. Un entretien **informel** naît davantage d'une demande du patient ou du soignant, souvent à la suite d'un événement, par exemple une crise d'angoisse ; son horaire et sa durée ne sont pas fixés d'avance.

Un entretien peut être **individuel** ou **familial**. Dans ce dernier cas, il importe d'être attentif aux besoins du patient et à ce qui peut être partagé avec les proches ; l'entretien avec la famille n'annule pas le caractère professionnel et confidentiel des échanges.

La confusion explicitement corrigée à l'oral est la suivante : **un entretien informel peut être directif**, et un entretien formel peut recourir à des questions ouvertes. L'organisation d'une rencontre ne dit pas, à elle seule, comment le soignant conduit la discussion.

Repères comparatifs

Axe	Question à se poser	Possibilités
Organisation	Est-il prévu et cadré ?	Formel / informel
Participants	Avec qui échange-t-on ?	Individuel / familial
Technique	Comment le dialogue est-il guidé ?	Directif / semi-directif / non directif

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Un patient interroge spontanément l'IDE sur son médicament pendant la tournée : l'entretien est informel. Si la réponse reste centrée sur quelques questions précises, il peut être plutôt directif.

03 Directif, semi-directif, non directif

ESSENTIEL

Les trois techniques se distinguent par la place des questions préparées, le degré de guidage et l'espace laissé à l'expression du patient. **Aucune ne supprime la finalité du soin.**

POUR COMPRENDRE

Directif (dirigé). Le soignant prépare une liste de questions ciblées, souvent fermées. Le patient répond de manière discontinue ; l'objectif est précis, par exemple un recueil d'éléments sur les habitudes de vie, des consommations ou des antécédents. Le support cite les questionnaires, grilles, audits et le repérage précoce avec intervention brève.

Semi-directif. Des thèmes et éventuellement une grille sont préparés, mais les questions ouvertes permettent d'accueillir des réponses plus développées. Le soignant écoute sans jugement, relance et ajuste l'exploration ; la grille sert de fil conducteur, pas de script rigide.

Non directif (libre). Le soignant pose un cadre d'exploration, puis laisse davantage de continuité au discours du patient. Cela peut aider à faire émerger un besoin ou une préoccupation non anticipée. Cette forme exige une véritable maîtrise de l'écoute, des reformulations et du recentrage.

Le témoignage oral montre qu'avec l'expérience, le soignant peut être moins dépendant de sa feuille de questions tout en gardant l'objectif. Ce n'est pas une invitation à improviser sans préparation.

Repères comparatifs

Technique	Guidage	Questions / outils
Directif	Très ciblé	Questions souvent fermées ; grille
Semi-directif	Thèmes prévus, souplesse	Questions ouvertes ; écoute active
Non directif	Expression plus libre dans un cadre	Ouverture, silences, reformulation

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Question fermée : « Fumez-vous actuellement ? » Question ouverte : « Comment vivez-vous ce traitement au quotidien ? » Le choix dépend de l'information recherchée et de la disponibilité du patient.

04 Entretien d'accueil et recueil de données

ESSENTIEL

L'entretien initial vise à **établir une relation de confiance** et à obtenir les informations nécessaires à une prise en soins pertinente.

POUR COMPRENDRE

Les éléments recherchés peuvent concerner le vécu, les besoins, les habitudes de vie, les antécédents, l'état clinique et les questions du patient. Le soignant adapte son interrogation : un questionnaire trop serré risque de ne pas laisser apparaître les informations spontanées ; un échange trop libre peut faire oublier des éléments importants.

Il informe aussi sur le déroulement de la prise en soins et répond aux préoccupations exprimées. Le support n'impose pas un questionnaire unique : le contenu se choisit selon le contexte et les objectifs.

Distinction cruciale apportée par PT02 : l'« entretien d'accueil » est un *type d'entretien* consacré notamment au recueil de données ; la « phase d'accueil » est seulement l'ouverture de *n'importe quel entretien*. On n'y réalise donc pas nécessairement un recueil de données complet.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

À l'admission, demander les habitudes de vie peut faire partie de l'entretien initial. En revanche, ouvrir un entretien de soutien par une présentation et un rappel du cadre ne signifie pas qu'on recommence le recueil d'admission.

05 Informer et réaliser des soins éducatifs

ESSENTIEL

Informer consiste à expliquer et répondre aux questions. **Éduquer** implique en plus d'évaluer les connaissances et d'accompagner un apprentissage.

POUR COMPRENDRE

L'entretien informatif transmet ou recueille des informations sur l'état de santé, les traitements et les soins, à destination du patient et, selon le cadre pertinent, de son entourage. L'oral précise que ce n'est pas une récitation technique : les explications doivent être ajustées aux réactions et questions de la personne.

L'entretien de soins éducatifs s'inscrit dans une démarche : identifier les connaissances préalables et les besoins, compléter l'information, proposer des apprentissages et apprécier ce que la personne sait ou sait faire. Le support mentionne l'apprentissage de gestes techniques ; l'oral donne l'exemple d'une personne diabétique apprenant un

geste lié à son insuline.

Un même temps d'échange peut contenir de l'information et une dimension éducative ; ce sont les objectifs et les démarches mises en œuvre qui les distinguent.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Pour un geste technique, le soignant ne s'arrête pas à « je vous l'ai expliqué » : il vérifie les prérequis et ce que le patient a compris ou peut refaire dans les conditions du soin.

06 Entretien d'aide et de soutien : relation d'aide

ESSENTIEL

L'objectif est de **favoriser l'expression du vécu et des difficultés** pour accompagner la personne, pas de lui imposer une solution.

POUR COMPRENDRE

Le support renvoie à la relation d'aide de **Carl Rogers**, et cite une approche centrée sur la personne : empathie, congruence, authenticité, bienveillance, disponibilité et **non-jugement**. Les outils incluent l'exploration, la clarification, la reformulation et l'écho.

À l'oral, la formatrice décrit un patient qui exprime ou laisse percevoir une souffrance émotionnelle. L'IDE cherche à accueillir ce vécu, y compris quand il n'est pas formulé d'emblée. L'entretien peut aider à identifier les ressources, compétences et capacités du patient et à les valoriser.

Une difficulté majeure est de rester présent sans banaliser ni « remplir » trop vite l'espace par des conseils. La congruence implique aussi d'être attentif à la cohérence entre les paroles, la posture et les expressions observables.

La formatrice évoque des situations de maladie grave et de fin de vie : l'entretien peut accueillir la peur, la colère ou la tristesse. Cela demande une posture professionnelle ajustée, pas une réponse standardisée.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Face à « J'ai peur de ce qui va m'arriver », inviter le patient à préciser son inquiétude et reformuler ce qui est compris est différent de répondre immédiatement « Ne vous inquiétez pas ».

07 Négocier sans imposer

ESSENTIEL

La négociation cherche une **décision éclairée et un compromis lorsque cela est possible**, dans le respect de la possibilité de choix du patient.

POUR COMPRENDRE

Le support associe l'entretien de négociation à l'adhésion aux soins, à la décision du patient, aux éléments nécessaires pour comprendre les enjeux et à la distinction entre ce qui est négociable ou non. Une explication claire des contraintes et des options fait partie de l'échange.

La formatrice développe un exemple important : face au refus d'une toilette, le but n'est pas d'obtenir immédiatement le soin à l'heure prévue par l'organisation. Avant toute négociation, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne refuse, ce qui l'inquiète ou ce qui ne lui convient pas. Son **libre arbitre** reste un élément central.

Il faut aussi distinguer une règle de sécurité qui ne peut pas être ignorée et les modalités d'organisation qui peuvent être adaptées. Ce raisonnement est contextuel : le support ne fournit pas de catalogue exhaustif d'actes négociables ou non négociables.

L'oral rappelle que le professionnel ne doit pas se présenter comme « celui qui sait tout » : l'entretien aide la personne à prendre conscience de ses ressources et à contribuer à la décision.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Un refus de toilette appelle d'abord l'écoute et l'exploration des motifs ; envisager un autre horaire peut être une option lorsque la situation et l'organisation le permettent.

08 Recadrer : rappeler un cadre sans confondre les situations

ESSENTIEL

Un entretien de recadrage est une **démarche construite** autour d'une règle, d'une limite ou d'un comportement problématique ; il ne se réduit pas à une remarque ponctuelle.

POUR COMPRENDRE

Le support prévoit le recadrage dans des situations de management ou de non-respect du cadre par un patient ou son entourage. À l'oral, la formatrice souligne qu'un rappel immédiat d'une interdiction n'est pas automatiquement un « entretien de recadrage » formalisé.

Le recadrage peut consister à rappeler le sens des règles et leurs conséquences, à expliquer les limites et à rechercher une compréhension. Il peut donc mobiliser une dimension informative, sans être uniquement une posture autoritaire.

La formatrice évoque des entretiens menés avec des membres d'équipe pour rappeler des attentes professionnelles. Les exemples relatifs aux familles ou aux situations institutionnelles doivent être replacés dans

le contexte réel, sans généralisation juridique au-delà du cours.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Dire à un patient que fumer dans sa chambre est interdit constitue un rappel immédiat de règle. Organiser un échange structuré autour de comportements répétés et du cadre de soins peut relever d'un entretien de recadrage.

09 Entretien motivationnel : faire émerger le changement

ESSENTIEL

L'entretien motivationnel est **collaboratif et centré sur le patient** ; il vise à faire émerger ou renforcer une motivation interne et à explorer l'ambivalence.

POUR COMPRENDRE

Le support cite notamment **Miller et Rollnick** et **Margot Phaneuf** : on accompagne une personne lorsqu'un changement de comportement serait souhaitable pour sa santé, sans lui imposer ce changement. L'orientation vers un objectif ne signifie pas interrogatoire ni pression.

L'oral s'appuie longuement sur l'addictologie. Une personne peut dire que sa consommation ne lui pose aucun problème, puis évoquer des conséquences contradictoires avec cette première affirmation. Le rôle du soignant est d'aider à explorer ce décalage, avec des questions adaptées et sans jugement ; la prise de conscience appartient à la personne.

La formatrice distingue explicitement cet entretien de la simple action consistant à encourager quelqu'un à « garder le moral ». La motivation au changement n'est pas identique au soutien émotionnel général.

Cet outil est présenté comme utilisable dans différents champs, même si l'addictologie constitue son exemple dominant pendant la séance.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Question possible : « Qu'est-ce qui vous convient dans votre situation actuelle ? Et qu'est-ce qui vous gêne parfois ? » Cette formulation ouvre l'exploration de l'ambivalence sans affirmer à la place du patient ce qu'il doit faire.

10 Étape 1 — préparer l'entretien

ESSENTIEL

Avant la rencontre, le soignant précise **l'objectif et les modalités** de l'entretien ; dans l'informel, l'anticipation complète n'est pas toujours possible.

POUR COMPRENDRE

Le support propose de planifier le **lieu**, le **moment**, la **durée**, le **type d'entretien** et les outils. Préparer des thèmes ou des questions peut aider à ne pas manquer les informations nécessaires ; leur emploi reste adaptable.

L'oral insiste sur le caractère intentionnel de ce travail : quelles informations sont nécessaires et quelles questions peuvent les faire apparaître ? Un recueil peut être large ou très ciblé selon le but.

La disponibilité de la personne et l'environnement comptent déjà dans cette préparation. Un moment mal choisi ou un lieu bruyant risque de compromettre un échange qui aurait été pertinent à un autre moment.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Avant un entretien programmé d'explication, identifier ce que le patient sait déjà, les points à aborder et les conditions d'intimité disponibles.

11 Étape 2 — commencer et orienter

ESSENTIEL

L'ouverture associe **présentation, cadre, disponibilité et consentement** de la personne à entrer dans l'échange.

POUR COMPRENDRE

L'IDE précise sa fonction, le motif de la rencontre, ses objectifs et une durée indicative. Il adopte une posture engageante et cherche à savoir si la personne est disponible, prête à écouter ou à parler, et dans quel état d'esprit elle se trouve.

Le support fait de la disponibilité et du consentement de la personne une question explicite. L'oral renforce cette exigence : un entretien bien préparé ne doit pas être déroulé mécaniquement si la personne ne se sent pas prête.

L'ouverture n'est pas l'entretien d'accueil au sens du recueil initial. Cette distinction mérite un rappel systématique dans les cas de QCM.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

« Je suis l'infirmière du service. Je voudrais vous proposer un échange d'environ quinze minutes pour répondre à vos questions sur la suite du soin. Est-ce un bon moment pour vous ? »

12 Étape 3 — explorer et exploiter

ESSENTIEL

Le corps de l'entretien repose sur l'**écoute active**, l'observation, les questions ajustées, la reformulation et le respect des silences.

POUR COMPRENDRE

Les outils sont choisis selon l'objectif : questions ouvertes ou fermées, exploration, clarification, reformulation, observation du verbal et du non-verbal, écho, renforcement positif. L'attitude recherchée est congruente, authentique et empathique.

Le support nomme la **proxémie** parmi les attitudes à considérer. La distance, le placement et le contexte doivent être adaptés à la personne et à la situation ; ce n'est pas une distance chiffrée universelle donnée dans ce cours.

À l'oral, la formatrice insiste : ne pas craindre le silence, ne pas finir une phrase hésitante à la place du patient, observer si son expression concorde avec ce qu'il dit. Il faut permettre au discours de se développer tout en gardant en tête la finalité du soin.

Le renforcement positif vise à reconnaître une ressource ou un effort réel du patient plutôt qu'à distribuer des compliments automatiques.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Une personne dit « Tout va bien » tout en paraissant préoccupée : plutôt que de conclure à une contradiction certaine, l'IDE peut proposer « Vous me dites que ça va, et je vous sens préoccupé ; souhaitez-vous m'en dire plus ? ».

13 Étape 4 — conclure de manière explicite

ESSENTIEL

La fin de l'entretien doit être **annoncée** et comprendre une synthèse ainsi qu'une appréciation des objectifs atteints.

POUR COMPRENDRE

Le support prévoit d'annoncer la fin, de reformuler les points abordés, de vérifier ce qui a été obtenu, d'envisager si nécessaire une prochaine rencontre, puis de valoriser, remercier et saluer.

Dans PT02, la formatrice indique qu'un objectif peut être atteint, partiellement atteint ou non atteint. Cette distinction permet de ne pas confondre une rencontre terminée avec un objectif obligatoirement réalisé.

Si le besoin demeure ou si le temps n'a pas permis de tout explorer, la suite peut être discutée avec la personne. La conclusion est donc une vraie étape clinique et relationnelle, pas seulement une formule de politesse.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

« Nous avons éclairci les questions sur votre soin, mais il reste votre inquiétude concernant le retour à domicile. Nous pouvons prévoir un autre échange pour approfondir ce point. »

14 Étape 5 — évaluer et transmettre

ESSENTIEL

Après l'entretien : prendre du recul sur les leviers et freins rencontrés, puis faire des **transmissions orales et écrites pertinentes**.

POUR COMPRENDRE

Le support appelle cette phase « évaluation & transmissions ». Le débriefing consiste notamment à identifier ce qui a aidé ou freiné la rencontre, les ajustements possibles et les éléments utiles à la continuité des soins.

L'oral souligne la nécessité de transmettre à l'équipe, tout en restant **synthétique**. L'IDE ne retranscrit pas systématiquement chaque question, chaque réponse ou la totalité de confidences très sensibles. Il consigne les

informations utiles au suivi, dans le cadre de la confidentialité professionnelle.

Il faut distinguer : **l'évaluation avec le patient** lors de la conclusion, puis **le retour professionnel et la transmission** à l'issue de l'entretien. Les deux sont présents dans la séance.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Transmettre le besoin identifié, les décisions ou suites convenues et les observations pertinentes plutôt que copier mot à mot le récit personnel d'une personne.

15 Ce qui facilite ou freine un entretien

ESSENTIEL

La qualité de l'entretien dépend à la fois de la **posture**, de la **disponibilité**, du **cadre** et de la situation clinique de la personne.

POUR COMPRENDRE

Les trois diapositives de synthèse listent des éléments proches parfois répétés. Il faut les rapprocher sans les empiler : un lieu calme et intime, des objectifs clairs annoncés, un moment approprié, l'engagement réciproque, l'empathie, la congruence, la bienveillance, le respect et l'absence de jugement favorisent les échanges.

À l'inverse, la douleur, la colère, la tristesse, le déni, certains troubles cognitifs, une disponibilité limitée, le bruit, la méfiance, des différences culturelles ou des croyances mal prises en compte, une barrière de langue ou une posture stigmatisante peuvent compliquer la rencontre.

L'oral cite **l'interprétariat** comme ressource possible pour surmonter une difficulté linguistique, en fonction des possibilités du service. La formatrice rappelle aussi qu'une situation d'entretien éprouvante peut nécessiter de solliciter l'équipe ou de travailler en binôme. Ce témoignage ne constitue pas une règle universelle. Le support mentionne aussi les mécanismes de défense, la sympathie, le transfert et la projection parmi les freins possibles, sans les développer davantage dans ces diapositives.

Repères comparatifs

Favoriser	Risque / frein	Ajustement possible
Lieu calme / intimité	Bruit, passages	Chercher un espace adapté
Disponibilité mutuelle	Fatigue, douleur, crise	Revoir le moment si possible
Écoute / non-jugement	Stigmatisation, impatience	Questionner et reformuler
Langage accessible	Barrière de langue	Recourir à un interprète si possible
Objectifs partagés	Échange perçu comme imposé	Expliquer le cadre et demander l'accord

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Avant d'aborder une consommation problématique aux urgences, chercher autant que possible un endroit offrant de l'intimité plutôt que discuter dans un couloir où d'autres personnes entendent.

16 Raisonner en situation : trois mini-cas

ESSENTIEL

Pour un examen, identifier d'abord **la finalité**, puis **la technique**, les **étapes** et les **ajustements** possibles.

POUR COMPRENDRE

Cas 1 — refus de soin. Une personne refuse sa toilette. Ne pas réduire la négociation à « réussir le soin ». Explorer les raisons, respecter la décision du patient et envisager les modalités discutables lorsque c'est approprié.

Cas 2 — inquiétude. Une personne exprime sa peur d'une maladie. L'entretien d'aide et de soutien favorise l'expression, l'écoute et la compréhension du vécu ; il ne se limite pas à donner de l'information.

Cas 3 — suivi d'une consommation. La personne minimise les conséquences de ses consommations tout en évoquant certaines difficultés. L'entretien motivationnel aide à explorer l'ambivalence ; l'objectif n'est pas de démontrer autoritairement qu'elle a tort.

Pour chacun : annoncer l'objectif, apprécier disponibilité et consentement, mener l'exploration sans jugement, conclure, puis transmettre ce qui est utile. Une même rencontre peut combiner plusieurs objectifs ; l'oral rappelle que les appellations ne sont pas une classification rigide universelle.

APPLICATION EN SITUATION DE SOIN

Réflexe d'analyse : « Quel besoin ou objectif ? Quelle technique de questions ? Quelle posture ? Quel résultat évalué ? Quelles transmissions utiles ? »

17 Pièges QCM / confusions à éviter

Formel ≠ directif. Le premier décrit l'organisation ; le second décrit le guidage des questions.

Informel ≠ absence de but. La rencontre peut être spontanée tout en poursuivant un objectif clinique.

Non directif ≠ conversation libre sans fin. L'expression est ample, mais le cadre et la finalité demeurent.

Entretien d'accueil ≠ phase d'accueil. Un type d'entretien n'est pas l'ouverture de toute rencontre.

Information ≠ éducation. La démarche éducative exige aussi l'évaluation des connaissances et des apprentissages.

Soutien ≠ entretien motivationnel. Accueillir l'émotion et explorer une motivation au changement ont des finalités différentes.

Négociation ≠ soin imposé. Le refus de soin demande de l'exploration, non une persuasion mécanique.

Recadrage ≠ remarque ponctuelle. Un rappel immédiat de règle ne constitue pas toujours un entretien structuré.

Conclusion ≠ fin sans bilan. Annoncer la fin, synthétiser, évaluer l'atteinte des objectifs et envisager la suite.

Transmettre ≠ tout recopier. La trace doit être pertinente et prudente avec les détails sensibles.

18 Synthèse générale — l'essentiel du cours

EN UNE LECTURE

L'entretien infirmier est un soin relationnel guidé par une finalité. Les catégories d'organisation, de participants et de technique ne se confondent pas. Les objectifs déterminent le choix des questions et des outils. Les cinq étapes conduisent de la préparation à des transmissions synthétiques ; la disponibilité, le consentement, l'écoute et le non-jugement traversent l'ensemble de la démarche.

- Avant : clarifier l'objectif, le cadre, le lieu, le temps et les outils.
- Au début : se présenter, annoncer le motif, vérifier disponibilité et accord.
- Pendant : écouter, reformuler, observer, respecter le silence et ajuster la conduite.
- À la fin : annoncer la conclusion, faire la synthèse et apprécier les objectifs.
- Après : identifier leviers/freins, transmettre les éléments réellement utiles.
- À tout moment : respecter les choix, les ressources et le rythme de la personne.

19 Définitions et mots-clés

Lexique de fin de fiche — termes structurants du cours

Entretien infirmier	Soin relationnel avec une finalité de soins précise et une interaction professionnelle.
Formel	Entretien planifié et cadré, aux objectifs annoncés, avec lieu et durée envisagés.
Informel	Entretien non nécessairement prévu, déclenché à la demande ou par un événement.
Individuel / familial	Classification selon la participation de la personne seule ou avec l'entourage.
Directif	Technique reposant sur des questions ciblées et préparées, souvent fermées.
Semi-directif	Technique avec thèmes prévus et possibilité d'expression ouverte guidée.
Non directif / libre	Technique qui laisse davantage de continuité au discours dans un cadre d'exploration défini.
Question fermée	Question appelant une réponse limitée, utile à un recueil ciblé.
Question ouverte	Question laissant à la personne de l'espace pour expliquer son vécu ou ses idées.
Recueil de données	Collecte d'éléments pertinents pour comprendre les besoins et la situation clinique.
Soins éducatifs	Démarche d'évaluation des acquis et d'accompagnement d'un apprentissage en santé.
Relation d'aide	Approche centrée sur la personne qui favorise l'expression de son vécu et de ses ressources.

Empathie	Effort de compréhension du vécu de l'autre sans confondre son expérience avec la sienne.
Congruence	Cohérence de la posture relationnelle, de l'expression et de ce qui est communiqué.
Authenticité	Attitude sincère et professionnelle qui ne joue pas un rôle artificiel.
Non-jugement	Accueil sans stigmatisation ou réduction de la personne à une étiquette.

Écoute active	Attention volontaire à ce que dit, exprime et manifeste la personne.
Reformulation	Restitution prudente du propos pour montrer l'écoute et vérifier sa compréhension.
Clarification	Demande de précision lorsqu'un mot ou un énoncé reste ambigu.
Écho	Reprise d'un élément exprimé pour inviter la personne à le développer.

Silence	Pause qui peut permettre à la personne de penser, ressentir ou poursuivre son expression.
Renforcement positif	Reconnaissance d'un effort, d'une ressource ou d'un comportement utile observé.
Négociation	Recherche de décision éclairée et, si possible, de compromis sans contraindre la personne.
Recadrage	Échange structuré rappelant règles ou limites face à une situation problématique.

Entretien motivationnel	Démarche collaborative visant à faire émerger la motivation personnelle au changement.
Ambivalence	Coexistence de raisons de changer et de raisons de rester dans la situation actuelle.
Motivation intrinsèque	Motivation que la personne identifie en elle-même, plutôt qu'une injonction externe.
Proxémie	Dimension spatiale de la relation, dont la distance et le placement pendant l'échange.

Phase d'orientation	Ouverture de l'entretien : présentation, motif, cadre, disponibilité et consentement.
Phase d'exploration	Développement du dialogue au regard de la finalité et des informations recueillies.
Conclusion	Annonce de la fin, synthèse, évaluation des objectifs et suites éventuelles.
Débriefing	Retour professionnel sur les freins et les leviers après l'entretien.

Transmissions	Communication pertinente des éléments nécessaires à la continuité des soins.